

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

- De las siguientes muestras remitidas para estudio microbiológico cual habría que sembrar en primer lugar:
A) Orina.
B) Heces.
C) Exudado faríngeo.
D) Líquido cefalorraquídeo.
- Una mujer, con síntomas de disuria y polaquiuria (micción dolorosa y frecuente), que vive en un pueblo distante 50 Km del Hospital más cercano con de laboratorio de Microbiología Clínica, acude al médico de cabecera que pasa consulta en el pueblo. Tras la consulta, el médico ordena una toma de muestra. La muestra da resultados positivos a nitritos y leucocitos en el estudio bioquímico. En su cultivo obtenemos crecimiento de bacterias gram -, coliformes, lactosa+, indol+, ureasa-, H₂S- ¿Cuál cree que es la toma de muestra más adecuada en este caso?
A) Orina
B) Sangre
C) Espudo
D) Sudor
- De los siguientes gérmenes, ¿cuál no es causante de ITU?
A) E. coli
B) Pseudomona sp
C) Candida sp
D) Neisseria gonorrhoeae
- ¿Qué requisitos no debe cumplir la muestra de orina que llega al laboratorio?
A) Muestra correctamente etiquetada
B) Petición debidamente cumplimentada
C) Muestra conservada de forma correcta
D) Debe llegar al laboratorio a las 24H de su recolección
- Para valorar un urocultivo como infección segura, ¿cuántas UFC/ml deberíamos encontrar en una placa inoculada con la muestra de orina?
A) Menos de 10.000UFC /ml
B) Entre 10.000 y 100.000 UFC/ml
C) Más de 100.000 UFC/ml
D) No debe aparecer ninguna colonia en la placa inoculada
- La extracción de sangre para cultivo, se llama:
A) Gasometría.
B) Hemograma.
C) Hemocultivo.
D) Hemobiograma.
- Ante una sospecha de sinusitis, ¿cuál sería la muestra de elección para el estudio microbiológico?
A) Aspirado sinusal.
B) Exudado nasal.
C) Exudado faríngeo.
D) Ninguna de las anteriores.
- Seleccionar el método más adecuado para la investigación de bacterias anaerobias:
A) Con un hisopo de algodón en el área del absceso
B) Con una tijera un trozo superficial de la piel
C) Por aspiración con aguja tras descontaminación superficial
D) Con un hisopo, usando un escalpelo para desbridar
- La causa más frecuente de diarrea nosocomial es:
A) Escherichia coli enteropatógena.
B) Clostridium difficile.
C) Campylobacter jejuni.
D) Shigella spp.
- Con relación a las muestras vaginales, señale la respuesta FALSA:
A) Los patógenos que suelen crecer en estas muestras son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis
B) Las torundas extraídas suelen sembrarse en medios adecuados, y después colocarse en 1 mL de suero salino para su estudio en fresco
C) También se suele añadir una gota de KOH a una gota de la secreción vaginal, y a esto se le llama test del olfato (olor pescado)
D) Los patógenos que crecen en estas secreciones producen vaginitis y vulvovaginitis.
- Por la mañana envían a laboratorio unas muestras de LCR y de orina para cultivo de bacterias. Dichas muestras han sido recogidas y refrigeradas durante



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

la noche. ¿Qué muestra rechazaríamos por no haber sido guardada adecuadamente?

- A) La muestra de LCR.
- B) La muestra de orina.
- C) Rechazaríamos las dos muestras.
- D) No rechazaríamos ninguna de las dos muestras.

12. Al laboratorio mandan una muestra de orina de una mujer que presenta polaquiuria, disuria. Para valorar el urocultivo como infección segura, ¿cuántas UFC/ml deberíamos encontrar en una placa inoculada con la muestra del paciente?

- A) Menos de 10.000 UFC/ ml.
- B) Entre 10.000 y 100.000 UFC/ ml.
- C) Más de 100 .000 UFC/ ml.
- D) No debe aparecer ninguna colonia en la placa inoculada.

13. Señale el enunciado correcto:

- A) Para el estudio de virus entéricos, no se pueden conservar las heces a 4° C cubiertas con glicerol.
- B) Para la investigación de microorganismos aerobios, el uso de torundas de algodón puede inhibir a *Chlamydia* spp.
- C) Para la investigación de microorganismos aerobios, el uso de torundas de dacrón no es útil para la investigación de virus.
- D) Para el diagnóstico de infecciones bacterianas, las heces conservadas en formol al 10 % son adecuadas para cultivo o detección de antígeno.

14. El agente microbiano, responsable en su mayoría de las infecciones genitourinarias, es:

- A) *Estafilococo aureus*.
- B) *Aspergillus*.
- C) *Salmonella*.
- D) *Escherichia coli*.

15. El autoanalizador detecta microorganismos en un frasco ¿Cuál sería la siguiente maniobra?

- A) Tinción de Giemsa
- B) Tinción de Gram
- C) Tinción de Gram y subcultivo
- D) Subcultivo

16. ¿Cuáles de las siguientes bacterias son causantes de meningitis en pacientes adolescentes?

- A) *Streptococcus agalactiae* y *Enterobacterias*
- B) *Escherichiacoli* y *Lysteria monocytogenes*
- C) *Neisseria meningitidis* y *Streptococcus pneumoniae*
- D) Cocos Gram positivos y *Escherichia coli*

17. La denominada otitis del nadador se relaciona etiológicamente con:

- A) *S. aureus*.
- B) *S. pyogenes*.
- C) *P. aeruginosa*.
- D) *B. pertussis*.

18. Los tapones de Dittrich se observan en:

- A) Edemas pulmonares.
- B) Tuberculosis.
- C) Bronquiectasias.
- D) Faringitis.

19. Señale la prueba en heces de utilidad diagnóstica en la infección por *Helicobacter pylori*:

- A) Cultivo microbiológico.
- B) análisis de anticuerpos anti *Helicobacter pylori*.
- C) análisis de antígenos de *Helicobacter pylori*.
- D) ninguna de las anteriores

20. Para la recogida de muestras de esputo, el paciente debe...

- A) Estar en ayunas.
- B) Lavarse los dientes.
- C) Enjuagarse con suero salino.
- D) Todas son correctas.

21. Algunos de los factores que contribuyen en las infecciones hospitalarias son:

- A) Mala técnica del lavado de las manos de los cuidadores.
- B) Manipulaciones en los sistemas intravenosos.
- C) Colocación de los catéteres en las urgencias.
- D) Todas son correctas.

22. Entre los distintos tipos de recogida de muestras biológicas, la de exudados se puede realizar por medio de la vía:

- A) Venosa.
- B) Capilar.
- C) Vaginal.
- D) Arterial.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

23. Diga cuál de las siguientes muestras son inaceptables para el cultivo de anaerobios:

- A) Contenido gástrico heces, hisopos rectales
- B) Espustos.
- C) Hisopos de encías.
- D) Todas son inaceptables**

24. De las siguientes muestras cuál no es adecuada para realización de un urocultivo:

- A) Orina de micción media
- B) Sondaje vesical transuretral
- C) Punción suprapúbica
- D) Orina de 24 horas**

25. El primer paso para la patogenicidad bacteriana es:

- A) La elaboración de toxinas.
- B) La adherencia.**
- C) El escape del sistema inmunitario.
- D) La formación de esporas.

26.Cuál de los siguientes microorganismos se encuentra como flora bacteriana en una vagina normal:

- A) Corinebacterias.
- B) Lactobacilos.**
- C) Anaerobios.
- D) Estafilococos coagulasa negativos.

27. El germen que provoca faringitis principalmente es:

- A) Streptococos grupos C y D
- B) Streptococo aureus
- C) Streptococo pyogenes**
- D) Streptococo agalactiae

28. ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia provoca infección del tracto urinario?

- A) Proteus mirabilis
- B) E. coli**
- C) Enterococcus
- D) Pseudomona

29. ¿Qué cantidad de muestra de hemocultivo es necesaria inocular para el crecimiento de microorganismos?

- A) De 2 a 4 ml
- B) De 1 a 4 ml
- C) De 5 a 10 ml**
- D) De 200 a 300 microlitros

30. ¿A qué temperatura se mantendrá la muestra de LCR para el cultivo de bacterias si no podemos procesarla inmediatamente?

- A) 35-37 °C**
- B) 25°C
- C) 4 °C
- D) 30°C

31. En condiciones de normalidad, la flora vaginal está compuesta por:

- A) Yersinia.
- B) Bacillus anthracis.
- C) Bacilos de Doderlain.**
- D) Pseudomonas.

32. Las bacterias más importantes causantes de faringitis bacterianas son:

- A) Staphylococo aureus.
- B) H. influenzae.
- C) Streptococos del grupo A.**
- D) Chlamydia.

33. A la hora de interpretar un resultado positivo de un urocultivo de orina obtenida por punción suprapúbica, es significativo un recuento de:

- A) $>10^2$ ufc/mL.
- B) $>10^3$ ufc/mL.
- C) $>10^5$ ufc/mL.
- D) Cualquier recuento es significativo.**

34. La causa bacteriana más frecuente de endocarditis es:

- A) S. viridans.
- B) S. pneumoniae.
- C) S. pyogenes.
- D) S. aureus.**



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

35. Respecto a la neumonía atípica, una de estas

afirmaciones no es correcta:

- A) La exploración física demuestra una disociación clínico-radiológica.
- B) Uno de sus principales agentes etiológicos en el *Mycoplasma pneumoniae*.
- C) Los virus respiratorios también pueden ser agentes causales.
- D) El cuadro clínico cursa, exclusivamente, con manifestaciones pulmonares.

36. En relación al diagnóstico y tratamiento de síndromes diarreicos:

- A) El periodo de incubación es fundamental para identificar la posible etiología microbiana.
- B) La mayoría de los síndromes diarreicos se curan con antimicrobianos.
- C) El estudio microbiológico sistemático es independiente de la clínica y del contexto del paciente.
- D) En general, las diarreas de causa no infecciosa se distinguen con facilidad (criterios NIDS)

37. ¿Cuál es el agente etiológico más habitual responsable de la faringitis?:

- A) *Streptococcus pyogenes*.
- B) *Corynebacterium diphtheriae*.
- C) Rinovirus.
- D) Virus de Coxsackie.

38. ¿Generalmente cómo se incuban las placas en las que se busca una infección bacteriana?

- A) 37°C durante 12h
- B) 35°C durante 24-48h
- C) 42°C durante 6 horas
- D) Temperatura ambiente durante 24 horas

39. ¿En qué placas se siembra la punta de catéter?

- A) Agar Sangre
- B) Agar MacConkey
- C) 1 tubo de Tioglicolato
- D) A y C son correctas

40. Respecto a la muestra de orina obtenida para cultivo es falso:

A) Se deben utilizar los primeros 20-25cc

- B) La muestra idónea es la primera de la mañana
- C) La orina debe ser procesada en menos de 1 hora o ser refrigerada
- D) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.

41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- A) Las muestras faringoamigdalares se toman con una torunda
- B) Las muestras nasofaríngeas se toman con torunda o aspirado
- C) Las muestras sinusales se toman por punción-aspiración
- D) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas

42. ¿Cuántos botes de hemocultivos positivos seriados deben darse para diagnosticar una septicemia continua o intermitente?

- A) Con uno es suficiente
- B) Ninguno
- C) Entre 2 y 3 hemocultivos
- D) Todas son ciertas.

43. En la toma de muestra de exudado nasal, ¿qué recomendación es correcta?

- A) En caso de ausencia de secreción se humedece la punta del hisopo en solución salina estéril y se introduce hasta la base de las fosas nasales, y se rota
- B) Retirar el hisopo con cuidado de la fosa nasal evitando que se contamine
- C) El paciente no debe estar en tratamiento con antibióticos, antialérgicos o antiinflamatorios
- D) Todas son correctas

44. ¿Qué es un hemocultivo?

- A) Un cultivo de hemoxidrina
- B) Un cultivo específico de virus en la sangre
- C) Un cultivo de microorganismos presentes en la sangre, a través de la cual se detectan infecciones transmisibles por el torrente sanguíneo.
- D) Todas las respuestas son falsas

45. Varón de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad y cardiopatía isquémica. Ingresa por presentar rachas de taquicardia ventricular sostenida. Tras cardioversión eléctrica, se insertó una vía central en la vena femoral derecha. Después de



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

una semana de ingreso sin complicaciones, el paciente comenzó al octavo día con fiebre de 38°C, precedida de tiritona. La exploración física fue normal y no presentaba disnea, tos ni dolor torácico. Se solicita al laboratorio de Microbiología urocultivo, hemocultivo seriado y cultivo de punta de catéter tras ser retirado. El urocultivo fue negativo. En los hemocultivos y cultivo de la punta de catéter se aislaron colonias *Staphylococcus Epidermidis*. ¿Cómo se debe remitir la punta del catéter al laboratorio de Microbiología?

- A) En torunda de alginato en medio de transporte
- B) En jeringa
- C) En recipiente estéril**
- D) En ninguno de los anteriores

46. Con respecto al volante de los hemocultivos hay que tener en cuenta:

- A) Es necesario un volante para cada solicitud de hemocultivo
- B) Debe indicar nombre y apellidos del paciente, fecha y hora de la extracción
- C) Debe indicar servicio de procedencia, número de cama, nombre del médico, diagnóstico y tratamiento previo
- D) Debe cumplir todos los requisitos anteriores**

47. Con respecto a los hemocultivos, es cierto:

- A) Se extraerán 10 ml de sangre por punción venosa que se inocularán en dos frascos de hemocultivos, uno para aerobios y otro para anaerobios
- B) Antes de la inoculación se limpiarán los tapones de los frascos de hemocultivos
- C) El nº recomendado de hemocultivos es de 2 a 3 utilizando siempre lugares diferentes de venopunción
- D) Todas son ciertas**

48. Indica cuál de los siguientes factores no afecta a la recuperación de microorganismos en el laboratorio a partir de un hemocultivo:

- A) El intervalo de extracción de los hemocultivos
- B) El volumen de sangre
- C) El método de obtención de la muestra
- D) El estado emocional del paciente.**

49. Que NO haremos con los hemocultivos seriados:

A) Se procesarán todos a la vez sin diferenciarlos

B) Se realizará una hoja de trabajo para cada uno de ellos

C) A su llegada al laboratorio de Microbiología se identificarán los volantes y los tubos de cada toma de muestra

D) Serán rechazados cuando existan dudas de identificación de la muestra o los frascos estén dañados y contaminados

50. De las siguientes respuestas, ¿Cuál NO es obligatoria que conste en la etiqueta de un frasco de hemocultivo?

- A) Nombre del paciente
- B) Nº de cama
- C) Hora de extracción
- D) Altura del paciente**

51. ¿Qué anticoagulante debe tener el medio de cultivo donde se realiza el hemocultivo con el sistema manual?

- A) SPS**
- B) EDTA
- C) CITRATO
- D) HEPARINA

52. ¿Cuál de las siguientes bacterias se aísla con mayor frecuencia en sangre?

- A) *Cándida albicans*
- B) *Haemophilus*
- C) *Staphylococcus aureus***
- D) *Bordetella pertussis*

53. ¿Qué microorganismos del tracto genital No se consideran patógenos?

- A) *Neisseria Gonorrhoeae*
- B) Citomegalovirus
- C) *Lactobacillus***
- D) *Gardinia SP*

54. Si hay un cultivo en orina se aíslan > 100.000 UFC/ml de 5 gérmenes diferentes:

- A) hay infección renal
- B) hay infección de la vejiga
- C) se considera probable contaminación fecal**
- D) se considera cultivo negativo



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

55. Ante el frasco de hemocultivo positivo, ¿qué tenemos que hacer?

- A) Aspirar asépticamente de 3 a 5 ml de caldo del frasco
- B) Depositar una gota del contenido del frasco en un portaobjetos para realizar una tinción con la técnica de Gram
- C) Hacer pase a Agar sangre, agar MacConkey y Agar chocolate
- D) Todo es correcto

56. ¿El crecimiento de qué bacterias puede inhibir el Polianetol Sulfonato de Sodio?

- A) Algunos streptococcus
- B) Gardnerella Vaginalis
- C) Algunas Neisseria
- D) Todas las respuestas son ciertas

57. En las infecciones nosocomiales debida a agentes microbianos (señale la RESPUESTA INCORRECTA):

- A) Son contraídas por un microorganismo de persona a persona
- B) Son contraídas por una infección exógeno
- C) Son contraídas por una infección ambiental
- D) Son contraídas por agentes desinfectantes

58. De los siguientes métodos de hemocultivo ¿Cuál no existe?

- A) Manuales o convencionales
- B) Semiautomatizados
- C) Naturales
- D) Automatizados

59. Para establecer el diagnóstico de bacteriemia por Staphylococcus Epidermidis asociada al catéter en nuestro caso:

- A) Debe haber crecimiento en el cultivo del catéter
- B) Debe haber crecimiento en los hemocultivos
- C) Se tiene que cumplir A y B
- D) Ninguna es correcta

60. En la obtención de muestras para hemocultivo es cierto que...

- A) Si se realizan varias tomas, todas deben tomarse de la misma vena

B) Cuando se sospecha la infección de un catéter, se debe tomar una muestra de los dos brazos

- C) Las muestras procedentes de catéter son preferibles a las de vena
- D) Nunca se debe realizar la extracción de una arteria

61. Si hubiera que comenzar lo antes posible un tratamiento para septicemia probable, ¿cómo se procedería a la obtención de muestra para los hemocultivos?

- A) Igual que si no necesitara tratamiento inmediato
- B) En este caso, no se hace hemocultivo, se manda una muestra de suero a la sección de Serología
- C) Se realizan a la vez dos extracciones de sangre en punciones diferentes antes de administrar el tratamiento antimicrobiano
- D) Todas son ciertas

62. ¿Ante la sospecha de una posible infección en una derivación ventrículoatrial, qué muestras microbiológicas recomendaría?

- A) LCR extraído por punción lumbar + hemocultivo.
- B) LCR extraído por punción reservorio valvular + hemocultivo.
- C) No es necesaria la toma de muestras microbiológicas hasta que no haya una clara sospecha de infección por medio de la bioquímica del LCR.
- D) Escobillón nasofaríngeo para ver la flora residente.

63. Se realizan dos tomas de LCR del reservorio valvular (una al día siguiente y otra a los tres días de la primera extracción) y en todas ellas se aisló la misma bacteria. El paciente presentaba clínica y alteración bioquímica en LCR. Ante estos datos el diagnóstico sería:

- A) Se trata de una infección valvular.
- B) Es una contaminación.
- C) Es una colonización.
- D) Con los datos aportados no se puede realizar un diagnóstico

64. ¿Cuál de los siguientes patógenos es el causante de la escarlatina?

- A) Streptococcus pyogenes.
- B) Streptococcus agalactiae.
- C) Streptococcus del grupo viridans.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

D) *Streptococcus pneumoniae*

65. Hombre de 60 años hospitalizado es diagnosticado de una bacteria relacionada con el catéter venoso central. El laboratorio de Microbiología informa que en todos los frascos de hemocultivos se observan cocos grampositivos en racimos. La PCR directa de la sangre del hemocultivo detecta la presencia de ADN específico de *Staphylococcus aureus* y la positividad del gen *mecA*. Ante esta información, ¿cuál es la interpretación correcta?

A) Se trata de un microorganismo productor de betalactamasa por lo que se puede iniciar tratamiento con cualquier antibiótico betalactámico menos penicilina/amoxicilina.

B) A la hora de decidir el tratamiento, habría que asumir la resistencia a todos los antibióticos betalactámicos y carbapenémicos con la excepción de ceftarolina.

C) El tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico intravenoso es la opción de tratamiento más recomendable.

D) En este caso se puede iniciar tratamiento con un antibiótico de amplio espectro como el meropenem.

66. En la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo de un paciente inmunodeprimido con sospecha de meningitis, se observan abundantes células polimorfonucleares y escasos bacilos Gram positivos de pequeño tamaño. Indique el posible microorganismo responsable de la infección:

A) *Neisseria meningitidis*

B) *Haemophilus influenzae*

C) *Streptococcus agalactiae*

D) *Listeria monocytogenes*

67. Señalar cuál es el método de referencia para el estudio de sensibilidad de las bacterias anaerobias

A) Método de dilución en agar.

B) Técnica de E-test.

C) Método de difusión con discos en agar.

D) Método de microdilución en caldo.

68. En relación a la historia natural del virus de la Hepatitis B ¿cómo interpretaría el siguiente perfil?: ADN Neg, HBsAg Pos, HBeAg Neg, HbeAC Pos, HBsAC Neg, AC core Pos

A) Fase inmunoactiva.

B) Portador inactivo.

C) Virus B oculto.

D) Infección pasada.

69. ¿Cuál de los siguientes virus NO se considera neurotrópo?

A) Virus varicela-zóster.

B) Herpesvirus humano de tipo 6.

C) Virus de Epstein-Barr.

D) Herpesvirus humano de tipo 8.

70. El virus respiratorio sincitial es el principal causante de:

A) Encefalitis.

B) Faringitis.

C) Diarrea en niños.

D) Bronquiolitis.

71. ¿Cuál de las siguientes bacterias es causante de artritis séptica en niños?

A) *Helicobacter cinaedi*.

B) *Klebsiella oxytoca*.

C) *Pseudomonas aeruginosa*.

D) *Kingella kingae*.

72. La bacteria más frecuentemente aislada en las infecciones urinarias es:

A) *Escherichia coli*

B) *Bacillus anthracis*

C) *Neisseria*

D) *Staphylococcus saprophyticus*

73. En cuanto a la recogida de muestras de esputo, señale la afirmación correcta

A) Explicar al paciente las normas de recogida.

B) Proporcionar al paciente un recipiente estéril adecuado.

C) Si la tos no es productiva, utilizar nebulizadores o fisioterapia para obtener la muestra.

D) Todas son correctas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES
TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

74. En general, la recogida de esputo para su análisis debe proceder de
A) Vías respiratorias bajas.
B) Vías respiratorias altas.
C) Saliva.
D) Faringe.
75. ¿Qué bacterias de las siguientes se aíslan con mayor frecuencia en hemocultivos?
A) *Staphylococcus aureus*.
B) *Candida albicans*.
C) *Bordetella pertussis*.
D) *Haemophilus*.
76. ¿Qué es la técnica de Maki?
A) Un antibiograma en placa.
B) Un API para identificación bacteriana.
C) Una técnica para siembra en placa de una punta de catéter.
D) Una prueba rápida de identificación para *Staphylococcus aureus*.
77. Ante una infección bacteriana grave generalizada (sepsis), ¿qué pruebas de laboratorio se solicitan para su diagnóstico? (señale la respuesta falsa):
A) Hemocultivo.
B) Procalcitonina.
C) Fórmula leucocitaria.
D) Glucemia basal.
78. Para el diagnóstico de la sífilis, no es útil realizar
A) la observación con microscopio de campo oscuro.
B) el cultivo del exudado cutáneo (chancro).
C) VDRL en LCR.
D) TPHA en suero.
79. Del cultivo de un exudado uretral aislamos gonococos, señala la característica correcta.
A) Son catalasa negativa y oxidasa positiva.
B) Son oxidasa negativa y catalasa positiva.
C) Puede crecer en agar sangre.
D) Existen pruebas de detección por ELISA y PCR.
80. Es el agente causal de más del 80 % de las cistitis agudas:
A) *Listeria monocytogenes*.
B) *Candida albicans*.
C) *Trichomonas vaginalis*.
D) *Escherichia coli*.
81. En cuanto a la recogida de muestras de orina para análisis microbiológico se ha de tener en cuenta:
A) Realizarla en ayunas.
B) Reservar la porción media de la micción.
C) Conservar la muestra entre 35-37 °C.
D) Utilizar un recipiente de vidrio común.
82. En caso de que una muestra de LCR, para estudio bacteriológico, no se pueda procesar inmediatamente se debe conservar:
A) En estufa a 35+/- 2 °C.
B) A temperatura ambiente.
C) Refrigerada para no afectar la viabilidad de *N. meningitidis* y *H. influenzae*.
D) A y B son correctas.
83. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la toma de hemocultivos:
A) Es esencial la correcta antisepsia de la piel y la prevención de la contaminación.
B) Es importante transportar la muestra al laboratorio rápidamente y mantenerla a temperatura ambiente.
C) Se recogen 2 o 3 extracciones por pacientes y, en el tiempo que transcurre entre la primera extracción y las siguientes, se deben refrigerar los frascos.
D) A y B son correctas.
84. ¿Cuál es la muestra de elección para el diagnóstico de meningitis fúngicas?:
A) Orina.
B) Sangre total.
C) LCR.
85. Paciente adolescente que acude a urgencias con fiebre elevada y ciertos signos neurológicos. Se le realiza punción lumbar para la obtención de LCR (líquido cefalorraquídeo) y punción venosa para el cultivo de sangre. ¿A qué temperatura se mantendrá



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

la muestra de LCR para el cultivo de bacterias si no podemos procesar inmediatamente?

- A) 30°C.
- B) 4°C.
- C) 25°C.
- D) 37°C.**

86. ¿Qué orina debe utilizarse para buscar gérmenes productores de infecciones de transmisión sexual?

- A) El primer chorro de micción.**
- B) El chorro medio de la micción.
- C) La orina de 24 horas.
- D) La orina de 12 horas.

Comentario. La orina es una muestra no habitual para búsqueda de patógenos de ETS y se encuentra limitada a pruebas de PCR de patógenos (según la SEIMC), con alguna excepción como las tricomonas que se pueden visualizar al microscopio. Casi todos estos patógenos colonizan la uretra y partes superficiales, de ahí que en caso de coger orina sea la de la primera parte. Recuerda que el medio más habitual es el exudado uretral, que debe recogerse si el paciente no ha orinado al menos las dos horas previas (por esa misma razón, para evitar que se pierdan los patógenos).

87. ¿Qué es Trichomonas vaginalis?

- A) Un hongo.
- B) Una bacteria.
- C) Un parásito.**

88. ¿Cuáles son los gérmenes que más frecuentemente aparecen como contaminantes de los hemocultivos?

- A) Escherichia coli.
- B) Enterococos.
- C) Staphylococcus epidermidis.**

89. ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia provoca faringitis?:

- A) Streptococcus aureus.
- B) Streptococcus agalactiae.
- C) Streptococcus pyogenes.**

90. ¿Cuál de las siguientes no sería una muestra del Tracto Respiratorio Inferior?

- A) Broncoaspirado.
- B) Líquido pleural.**
- C) Esputo.

91. Una muestra de líquido cefalorraquídeo que no se puede ser procesada de inmediato, ¿Dónde se conservará para un análisis microbiológico rutinario?

- A) Congelador a -80°.
- B) Estufa a 37°.**
- C) Congelador a -20°.

92. En las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿cuál de éstos es el agente causal más frecuente?

- A) Streptococcus viridans
- B) Haemophilus influenzae
- C) Bordetella pertussis
- D) Streptococcus pneumoniae**

93. ¿Cuáles de estos microorganismos NO se encuentran dentro del grupo HACEK?

- A) Haemophilus paraphrophilus.
- B) Aerococcus viridans.**
- C) Eikenella corrodens.
- D) Kingella kingae.

94. ¿En cuál de estas muestras NO es necesario realizar el cultivo en anaerobiosis?:

- A) Líquido ascítico.
- B) Líquido pleural.
- C) Líquido sinovial.
- D) LCR (Líquido cefalorraquídeo).**

Comentario. Si el LCR procede de una derivación, se debe incluir siempre cultivo en anaerobiosis

95. De estos microorganismos señale cuál aparece con más frecuencia en la bacteriemia asociada a catéter intravascular

- A) Klebsiella spp**
- B) Salmonella spp
- C) Yersinia spp
- D) Aspergillus spp



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

96. Una profesora de 22 años se trasladó al servicio de Urgencias con antecedentes de 2 días de evolución de cefalea y fiebre. El día de su ingreso, la paciente no había acudido a la escuela ni había llamado para dar una explicación. Al enterarse de esto, la madre de la profesora fue a su apartamento, donde encontró a la paciente en la cama, confusa y muy agitada. Cuando llegó a Urgencias, la paciente estaba semiinconsciente. Tenía lesiones purpúricas en el tronco y en los brazos. El análisis del LCR mostró 380 células/mm³ (93% de leucocitos polimorfonucleares), y una concentración de proteínas de 220 mg/dl y de glucosa de 32 mg/dl. La tinción de Gram del LCR reveló la presencia de numerosos diplococos gramnegativos, y este mismo microorganismo se aisló en la sangre y en el LCR. La paciente falleció a pesar del inicio precoz del tratamiento con penicilina. ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia es responsable de esta enfermedad fulminante?
- A) Streptococcus pneumoniae.
B) Escherichia coli.
C) Neisseria meningitidis.
D) Haemophilus influenzae.
97. La investigación del agente etiológico mediante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es:
- A) Más sensible que el cultivo en medios comunes.
B) Válida para la investigación de Virus, Bacterias, Hongos.
C) No nos permite conocer la sensibilidad antimicrobiana.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
98. ¿Cuáles de las siguientes bacterias son causantes de meningitis en pacientes adolescentes?
- A) Streptococcus agalactiae y Enterobacterias.
B) Escherichia coli y Lysteria monocytógenes.
C) Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae.
D) Cocos Gram positivos y Escherichia coli.
99. Si se recibe una muestra de orina para urocultivo, que no puede ser procesada inmediatamente, se conservará:
- A) En congelador por un período de 48 horas.
B) A temperatura ambiente por un período de 24 horas.
C) En frigorífico a 4º C por un período de 24 horas.
D) La muestra de orina debe siempre procesarse inmediatamente, nunca debe conservarse.
100. En relación con las muestras de esputo:
- A) Se recomienda recoger la muestra a primera hora de la mañana.
B) La muestra obtenida debe remitirse al laboratorio inmediatamente, y si no es posible, mantenerla en frigorífico.
C) La muestra obtenida debe remitirse al laboratorio inmediatamente, y si no es posible, mantenerla a temperatura ambiente.
D) Las respuestas A y B son correctas.
101. Son contaminantes comunes en los hemocultivos los:
- A) Estafilococos coagulasa positivos.
B) Estafilococos coagulasa negativos.
C) Estreptococos Alfa hemolíticos.
D) Estreptococos Beta hemolíticos.
102. En el caso de que se solicite urocultivo, ¿cuál sería la actitud correcta?
- A) No es necesario que la orina se recoja en frasco estéril.
B) La siembra se puede realizar en las primeras 72 horas desde la recogida de la muestra.
C) Se debe despreciar la orina de la primera parte de la micción, y a continuación recoger la orina en un recipiente estéril.
D) La muestra de orina se debe recoger a última hora de la noche.
103. Respecto a la etiopatogenia de la infección del tracto urinario, señale la respuesta correcta:
- A) La incidencia de las infecciones del tracto urinario no se relaciona con el sexo ni con la edad.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

B) La vía ascendente es la principal vía de infección.

C) *Staphylococcus saprophyticus* es el germen que con mayor frecuencia provoca infección del tracto urinario (75-90% casos).

D) La incidencia de las infecciones del tracto urinario no se relaciona con los periodos de máxima actividad sexual en la mujer.

104. ¿En qué situación se debe extraer una muestra para hemocultivo?

A) Antes de la administración de terapia antimicrobiana sistémica.

B) Después de la administración de terapia antimicrobiana sistémica.

C) Siempre que exista sospecha clínica de sepsis, meningitis, pielonefritis, infección intraabdominal o endocarditis.

D) Las respuestas A y C son ciertas.

105. Para el estudio microbiológico del LCR es recomendable:

A) Tubo estéril y con anticoagulante.

B) Recoger la muestra antes de la instauración del tratamiento antibiótico.

C) Elegir el último tubo extraído en la punción lumbar.

D) Las respuestas A y B son correctas.

106. Sobre la siembra y procesamiento de orina para identificación de patógenos urinarios, señale la respuesta correcta:

A) La siembra se realiza de manera cuantitativa, y para ello se usan asas calibradas de 100 µL.

B) Las placas se incuban habitualmente a 35-37°C en anaerobiosis.

C) Mediante espectrometría de masas MALDI-TOF se pueden identificar fiablemente la mayoría de patógenos urinarios.

D) Las técnicas basadas en las pruebas bioquímicas no están automatizadas.

107. ¿Cómo se llama el procedimiento en el cual se aplican ultrasonidos a la muestra para agitar sus partículas y

mejorar el diagnóstico microbiológico de las infecciones en las prótesis?:

A) Sonicación.

B) Sonorización.

C) Ultra centrifugación.

D) Deserción/ionización.

108. En Microbiología el hisopo Amies con carbón ¿en qué tipo de muestra se emplea?

A) Exudado endocervical.

B) Exudado uretral.

C) Exudado rectal.

D) Todas son correctas.

109. ¿Cuál es el microorganismo más implicado en las infecciones del tracto urinario (ITU)?

A) *Proteus mirabilis*.

B) *E. Coli*.

C) *Enterococcus*.

D) *Pseudomonas*.

110. ¿A qué temperatura debemos incubar las placas sembradas con la muestra de orina la paciente?

A) Temperatura ambiente.

B) 35°C-37°C.

C) 40°C.

D) 45°C.

111. ¿Qué característica cualitativa, de las que se enuncian a continuación, NO la reúnen las Enterobacterias?

A) Son bacilos Gram (-), producen endotoxinas, son anaerobios facultativos, oxidasa negativos y fermentadores de glucosa.

B) Forman parte de la flora intestinal normal del hombre.

C) En cualquier localización extraintestinal son patógenas.

D) Son cocos Gram (-)

112. ¿Cómo se realizaría la toma de muestra de orina?

A) Primero lavar el área periuretral con un antiséptico suave y enjuagar con abundante agua.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

B) Recoger en un recipiente apropiado la orina en cualquier momento del día, desechando la primera porción de la orina. Aunque es preferible la primera orina de la mañana con al menos tres horas de retención.

C) Desechar la primera orina de la mañana y recoger la orina 2 horas después.

D) Las respuestas A) y B) son ciertas.

113. ¿Cómo se realizaría el transporte al laboratorio?

A) En un recipiente estéril, translúcido y de boca ancha.

B) En un tubo de boca estrecha de 10 ml, que previamente se ha insertado en el sistema de aspiración de orina que tienen algunos recipientes de boca ancha.

C) Cualquiera de los dos recipientes anteriores.

D) En cualquier recipiente.

114. ¿Qué requisitos debe cumplir la muestra de orina que llega al laboratorio?

A) Muestra correctamente etiquetada.

B) Petición debidamente cumplimentada.

C) Muestra conservada de forma correcta.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

115. ¿Qué análisis nos confirmaría una infección de orina?

A) Hemocultivo.

B) Urocultivo.

C) Coprocultivo.

D) Hemograma.

116. De los siguientes medios de cultivo, ¿en cuál debemos sembrar una orina?

A) Agar MacConkey.

B) Agar Sangre.

C) Cled.

D) Todos los anteriores.

117. El Chancro blando o chancroide es un importante problema de salud en los países en vías de desarrollo que se presenta en forma de úlceras irregulares, blandas, dolorosas y de aspecto necrótico en los

genitales. Esta enfermedad de transmisión sexual es causada por:

A) Trichomonas vaginalis

B) Treponema pallidum

C) Klebsiella granulomatis

D) Haemophilus ducrey

118. El microorganismo más frecuente causante de Endocarditis Infecciosa es:

A) Cándida albicans.

B) Estafilococo coagulasa negativo.

C) Streptococos grupo viridans.

D) Staphylococcus aureus

119. Si la causa de infección es un microorganismo perteneciente a la propia flora comensal de un individuo, hablamos de:

A) Infección primaria.

B) Infección secundaria.

C) Infección exógena.

D) Infección endógena.

120. En el laboratorio de microbiología se recibe un esputo para cultivo y tinción de bacilos ácido-alcohol resistentes. En el examen microscópico con tinción simple (azul de metileno) se observan abundantes células epiteliales y escasos leucocitos. ¿Cómo cabe proceder a continuación?

A) Se trata de una contaminación orofaríngea y, por tanto, se debe contactar con el peticionario para solicitar nueva muestra insistiendo en la toma adecuada.

B) Que la calidad de la muestra no influye en su rendimiento para observar bacilos ácido-alcohol resistentes.

C) Tras esta evaluación previa con la tinción de azul de metileno se procede a teñir con tinción de Ziehl-Neelsen.

121. Antes de realizar una tinción de Gram en LCR, las muestras deben ser:

A) Filtradas.

B) Calentadas a 37°C.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

C) Centrifugadas.

D) Mezcladas.

122. ¿A qué muestras NO se le debe realizar una tinción de Gram?

A) Muestras respiratorias.

B) Puntas de catéter.

C) Líquidos de origen estéril.

D) Heridas.

123. ¿En qué momento del día es aconsejable hacer la extracción de sangre para hemocultivo?

A) En ayunas

B) En un pico febril

C) Por la tarde

D) Cada ocho horas

124. En una intoxicación alimentaria que se manifiesta tras un periodo de incubación corto de 2-4 horas sospecharemos de:

A) E.coli enterotoxigenico

B) Toxina clostridium perfringens

C) Toxina estafilococica

D) Toxina de clostridium botulinum

125. Marque la respuesta verdadera, en relación al estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo (LCR):

A) Las técnicas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) tienen mayor sensibilidad que el cultivo convencional y apenas se ven afectadas por el tratamiento previo con antimicrobianos.

B) Una vez obtenida la muestra, es necesario transportarla al laboratorio en el menor tiempo. Si esto no es posible, debe mantenerse refrigerada hasta su envío.

C) En las meningitis víricas el aspecto del LCR suele ser opalino o turbio, por la presencia de leucocitos.

D) Para la obtención de la muestra, la punción lumbar se debe realizar siempre en el espacio intervertebral L1-L2.

126. La tecnología MALDI-TOF para la identificación de microorganismos es:

A) Espectrofotometría de absorción atómica.

B) Quimioluminiscencia.

C) Citometría de flujo.

D) Espectrometría de masas.

127. ¿Qué cultivo microbiológico constituye el examen de confirmación de una septicemia (bacteriemia o fungemia)?

A) Urocultivo.

B) Hemocultivo.

C) Coprocultivo.

D) Todas son ciertas.

128. ¿Por qué se inocula sangre de un paciente con sospecha de sepsis en dos frascos con medio de cultivo?

A) Uno para el cultivo de microorganismos aerobios y otro para anaerobios

B) Uno para el cultivo de microorganismos habituales y otro para levaduras

C) Uno para el cultivo de micobacterias y otro para Cocos Gram +

129. Señala cuál de los siguientes síntomas no es característico de una septicemia.

A) Escalofríos

B) Reacción anafiláctica

C) Existencia de enfermedades subyacentes agudas

D) Pirexia >38°C

130. ¿A qué temperatura se deben almacenar las muestras de hemocultivos si no se pueden procesar inmediatamente?

A) A temperatura ambiente

B) En estufa de CO2 a 37 °C

C) En frigorífico a 4°C

D) En estufa a 37 °C

D) Uno para el cultivo de Cocos Gram + y otro para Gram -



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.6 al 13.8 Enfermedades bacterianas (respuestas)

- 131. La detección de nitritos en la tira reactiva de orina es un indicador de bacteriuria subyacente por gérmenes que reducen los nitratos a nitritos. ¿Cuál de las siguientes bacterias NO da positiva la prueba de los nitritos en orina?:**
- A) Escherichia coli.
B) Enterococcus faecalis.
 C) Proteus mirabilis.
 D) Pseudomonas aeruginosa
- 132. En un paciente cuyo cultivo ha sido realizado mediante punción suprapúbica, se considera que un recuento es significativo cuando la cantidad de unidades formadoras de colonias (ufc)/ml es mayor de:**
- A) >10 ufc/ml.
 B) >1.000 ufc/ml.
 C) >100.000 ufc/ml.
D) Cualquier recuento es significativo.
- 133. De las siguientes actuaciones cuál no estaría indicada en el estudio de un exudado uretral:**
- A) Tinción de Gram
 B) Siembra en Agar chocolate
 C) Siembra en medio de Thayer-Martin
D) Siembra en MacConkey
- 134. ¿Qué medio celular es el más frecuente para aislar chlamydias?**
- A) Cultivo en células McCoy**
 B) Cultivo en células HEP-2
 C) Cultivo en células FIBRO
 D) Cultivo en células VERO
- 135. Sobre la recogida de una muestra de esputo, ¿qué afirmación es falsa?**
- A) Recomendar al paciente que se enjuague la boca con un antiséptico antes de la recogida**
 B) Para facilitar la expectoración en pacientes no colaboradores, se puede administrar un nebulizador con una solución hipertónica de cloruro sódico
 C) Se recomienda la recogida del primer esputo de la mañana
 D) Se debe enviar rápidamente al laboratorio, o conservar en nevera a 4°C
- 136. Respecto de la conservación de las muestras de exudados nasofaríngeos para el diagnóstico molecular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- A) Se pueden conservar a 4 °C durante un máximo de 5 días.
 B) Se congelarán a -20 °C hasta su procesamiento.
C) Se pueden conservar a 4 °C durante un máximo de 72 horas.
 D) Se conservarán a temperatura ambiente hasta su procesamiento.
- 137. Qué microorganismo es el causante de la diarrea del viajero:**
- A) Campylobacter jejuni
B) Echerichia coli enterotoxigénico
 C) Shigella enterocolitica
 D) Yersinia enterocolitica
- 138. Para saber si la muestra de esputo es de buena calidad y representativa del foco de infección, teniendo en cuenta que el paciente no está inmunodeprimido, ¿qué hacer?**
- a) Inocular la muestra en los medios correspondientes e incubar durante 24-48 horas.
 b) Aplicar los criterios de Murray y Washington en la tinción de Gram. Si contiene > 25 leucocitos por campo (objetivo 10X) y > 10 células epiteliales por campo, se confirma que es de buena calidad.
 C) Aplicar los criterios de Murray y Washington en la tinción de Gram, Si contiene > 10 leucocitos por campo (objetivo 10X) y < 10 células epiteliales por campo, se confirma que es de buena calidad,
d) Aplicar los criterios de Murray y Washington en la tinción de Gram. Si contiene >25 leucocitos por campo (objetivo 100X) y < 10 células epiteliales por campo, se confirma que es de buena calidad.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases